ENFERMEDADES MALIGNAS DE CABEZA Y CUELLO

DR. PABLO DURAN

SITIOS DE CABEZA Y CUELLO

- Cavidad oral, orofaringe, nasofaringe, hipofaringe, laringe, cavidad nasal y senos paranasales, glándulas salivales, ganglios cervicales y piel.
- La mayoría de los tumores mucosos son carcinomas escamosos; la biología cambia con el sitio (VPH en orofaringe, EBV en nasofaringe).

FACTORES DE RIESGO

- Tabaco (dosis-dependiente) y alcohol (factor independiente, con sinergia).
- Exposición ocupacional, hábitos regionales y nuez de betel.
- Antecedente de cáncer de cabeza y cuello: riesgo de segundos primarios.
- Virus: VPH y EBV.

NIVELES GANGLIONARES CERVICALES

- I submentoniano/submandibular; II yugular superior; III yugular medio; IV yugular inferior; V triángulo posterior; VI compartimento central; VII mediastino superior.



DISECCIÓN CERVICAL

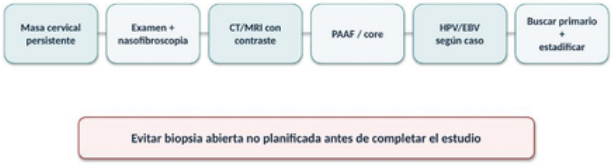
- Terapéutica: enfermedad ganglionar clínica o radiológica.
- Electiva: cuello cN0 con riesgo suficiente de enfermedad microscópica.
- Selectiva: niveles de mayor riesgo; radical o modificada según la extensión.

SÍNTOMAS DE ALARMA

- Úlcera oral persistente, masa cervical, disfonía persistente, disfagia u odinofagia.
- Otalgia referida con otoscopia normal, epistaxis u obstrucción nasal unilateral, pérdida de peso o hemoptisis.

MASA CERVICAL EN EL ADULTO

- Una masa persistente exige descartar malignidad; no asumir que una masa quística lateral es benigna.
- Estudio: examen, imagen con contraste (TC o RM), ultrasonido y PAAF como primera forma de obtener tejido.
- Evitar la biopsia abierta antes de completar el estudio.



Evitar biopsia abierta no planificada antes de completar el estudio

ESTADIFICACIÓN

- El TNM depende del sitio anatómico; la orofaringe VPH-asociada tiene sistema propio.
- AJCC 2026: Version 9 para orofaringe VPH-asociada, glándulas salivales y nasofaringe; otros sitios siguen con AJCC 8.

IMAGEN

- TC con contraste: evaluación global, hueso y adenopatías.
- RM: tejidos blandos, base de lengua, extensión perineural y base de cráneo.
- PET/CT: enfermedad avanzada y primario oculto; no sustituye la biopsia.

PRONÓSTICO

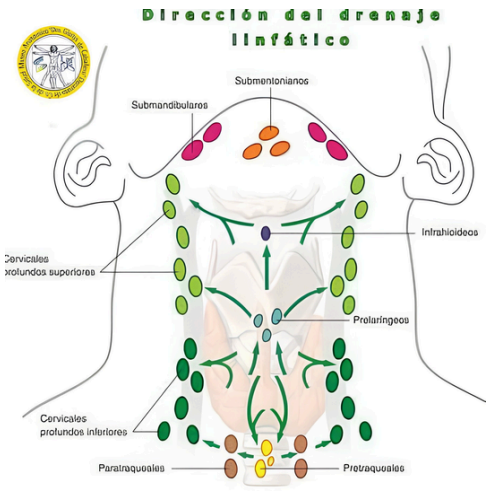
- Depende del estadio al diagnóstico, el estado VPH/EBV, los márgenes quirúrgicos y la extensión extranodal.

ENFERMEDADES MALIGNAS DE CABEZA Y CUELLO

DR. PABLO DURAN

PATRÓN DE DRENAJE GANGLIONAR

- Cavidad oral → niveles I–III. Orofaringe → II–III, puede ser bilateral.
- Laringe supraglótica e hipofaringe → II–IV. Nasofaringe → retrofaríngeos y II, a menudo bilateral.
- El patrón ayuda a buscar un primario oculto.



CAVIDAD ORAL Y OROFARINGE NO SON LO MISMO

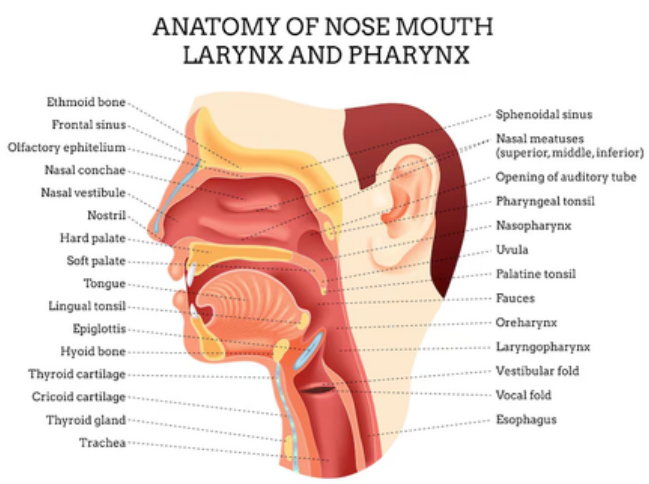
- La base de lengua pertenece a la orofaringe; la lengua oral son los 2/3 anteriores.
- Cavidad oral: labio mucoso, mucosa bucal, encías, trígono retromolar, piso de boca, paladar duro y lengua oral.
- Orofaringe: amígdalas palatinas, base de lengua, paladar blando y pared posterior.

LARINGE: ANATOMÍA CLÍNICA

- Supraglotis: rica red linfática, ganglios frecuentes.
- Glotis: pocos linfáticos, disfonía temprana.
- Subglotis: menos común; drenaje paratraqueal.

SUBSITIOS DE LA HIPOFARINGE

- Senos piriformes, pared posterior y región postcricoidea.



VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

- Especialmente VPH-16; predilección por amígdala palatina y base de lengua.
- Puede presentarse como adenopatía en pacientes sin gran exposición a tabaco.
- Mejor pronóstico promedio, pero no es un «cáncer inocuo».

p16

- Biomarcador por inmunohistoquímica fundamental en el carcinoma escamoso de orofaringe; modifica clasificación y pronóstico.
- No extrapolarlo automáticamente a otros subsitios.

VIRUS DE EPSTEIN-BARR (EBV)

- Biomarcador del carcinoma nasofaríngeo no queratinizante/endémico.
- Otros factores del nasofaríngeo: dieta rica en alimentos conservados con sal y antecedentes familiares.

MÁRGENES QUIRÚRGICOS

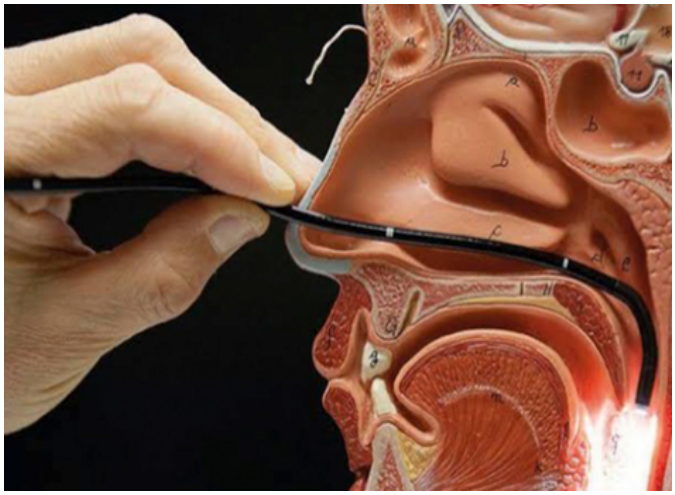
- Resección completa preservando función; orientar la pieza y comunicarse con patología.
- Un margen comprometido cambia el riesgo y el tratamiento adyuvante.

EXAMEN FÍSICO DIRIGIDO

- Inspección y palpación de la cavidad oral; palpación bimanual del piso de boca y la lengua.
- Movilidad lingual, trismus y pares craneales; todos los niveles cervicales; piel, cuero cabelludo y parótidas.

NASOFIBROSCOPÍA

- Valora nasofaringe, base de lengua, hipofaringe y laringe; documenta la movilidad de las cuerdas vocales.
- Busca asimetrías, ulceración y lesiones submucosas; no reemplaza la biopsia.



ENFERMEDADES MALIGNAS DE CABEZA Y CUELLO

DR. PABLO DURAN

ALGORITMO DEL GANGLIO SOSPECHOSO

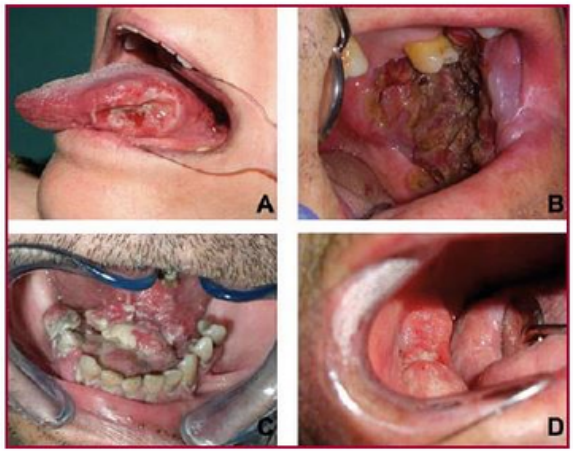
- Masa persistente → examen + nasofibroscopía → TC/RM con contraste → PAAF o core → VPH/EBV según caso → buscar primario y estadificar.

BIOPSIA DEL PRIMARIO

- Lesión visible → biopsia dirigida, planeada para no comprometer la resección.
- El informe identifica histología y biomarcadores; en orofaringe, establecer el estado VPH.

CARCINOMA DE CAVIDAD ORAL

- Lesión ulcerada o exofítica, indurada, con dolor tardío; lengua lateral y piso de boca.
- Evaluar invasión mandibular, profundidad y cruce de línea media; un cuello cN0 no siempre es microscópicamente negativo.



PROFUNDIDAD DE INVASIÓN (DOI)

- Se mide desde la membrana basal de la mucosa normal adyacente hasta el punto más profundo; no es el grosor tumoral.
- Influye en el T y en el riesgo de metástasis cervical.

TRATAMIENTO DE LA CAVIDAD ORAL

- Cirugía como tratamiento principal: resección del primario + manejo del cuello + reconstrucción planeada desde el inicio.
- Radioterapia o quimiorradiación adyuvante según factores patológicos.

OROFARINGE VPH-ASOCIADA

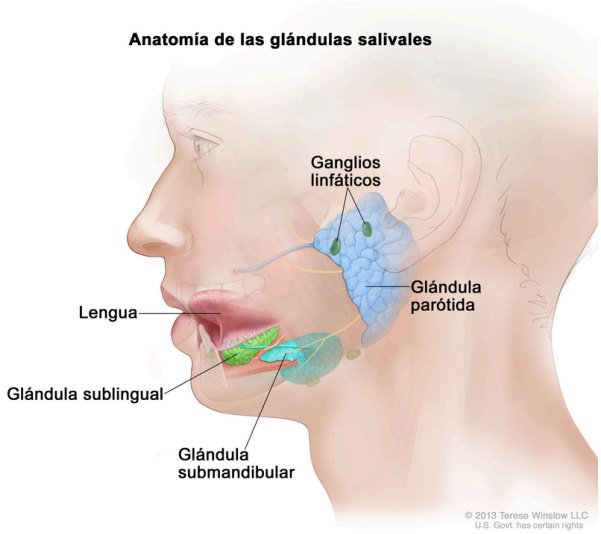
- Frecuente en amígdala o base de lengua; el primario puede ser pequeño con adenopatía prominente.
- p16/VPH es esencial para estadificación y pronóstico; manejo multidisciplinario.

VPH POSITIVO FRENTE A VPH NEGATIVO

- VPH+: adenopatía dominante, mejor pronóstico, estadificación específica.
- VPH- (tabaco/alcohol): exposición acumulada, más segundos primarios.

GLÁNDULAS SALIVALES

- Grupo muy heterogéneo; la parótida es la más afectada, pero muchos tumores son benignos.
- Tipos: adenoma pleomórfico (benigno), carcinoma mucoepidermoide y adenocarcinoma.
- Debilidad facial con masa parotídea: sospechar malignidad; cirugía como pilar.



PARÓTIDA Y PIEL

- Los ganglios intraparotídeos reciben metástasis de cáncer cutáneo de cara y cuero cabelludo; revisar la piel ante masa parotídea maligna.

PRIMARIO DESCONOCIDO

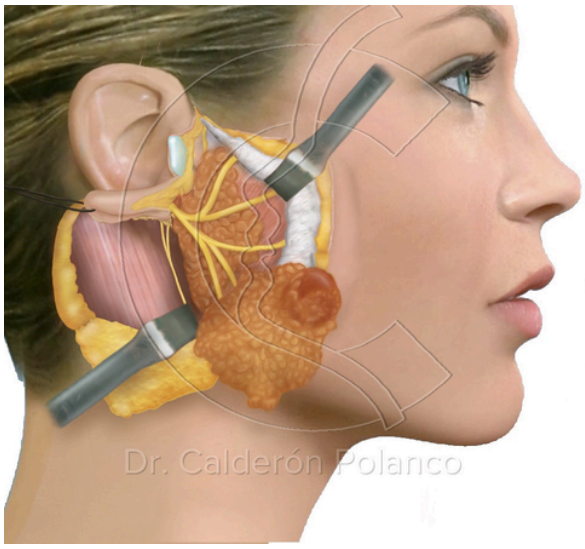
- SCC cervical sin primario tras la evaluación inicial; el nivel ganglionar y VPH/EBV orientan la búsqueda.
- PET/CT antes de procedimientos que inflamen, examen bajo anestesia y biopsias/tonsilectomía dirigidas.

DISECCIÓN RADICAL CLÁSICA

- Sacrifica nervio accesorio espinal (XI), vena yugular interna y músculo esternocleidomastoideo; las modificadas preservan uno o más.

ENFERMEDADES MALIGNAS DE CABEZA Y CUELLO

DR. PABLO DURAN



EXTENSIÓN EXTRANODAL (ENE)

- El tumor atraviesa la cápsula ganglionar: marcador de mayor riesgo que puede intensificar la adyuvancia.

TUMORES DE SENOS PARANASALES

- Se originan en senos paranasales o cavidad nasal: carcinoma escamoso, adenocarcinoma y melanoma.
- Congestión o hemorragia nasal persistente.

RADIOTERAPIA

- Definitiva o adyuvante; IMRT reduce la exposición de tejidos sanos; braquiterapia en casos seleccionados.
- Toxicidad: mucositis, xerostomía, disfagia, fibrosis, alteraciones dentales y osteorradionecrosis.

ADYUVANCIA POSQUIRÚRGICA

- Radioterapia ante T/N avanzados, márgenes cercanos, invasión perineural/linfovascular o múltiples ganglios.
- Márgenes positivos y ENE: alto riesgo, pueden justificar quimiorradiación.

ENFERMEDAD RECURRENTE O METASTÁSICA

- Valorar rescate quirúrgico o radioterápico; si no es curable: sistémico por biomarcadores, inmunoterapia, anticuerpos monoclonales y/o quimioterapia.